

Injúria renal aguda · abordagem

IRA = queda abrupta da TFG com retenção de escórias. Separe pré-renal, parenquimatosa e obstrutiva; trate causa, volume e hipercalcemia antes de 'só pedir creatinina de novo'.

Pistas de classificação

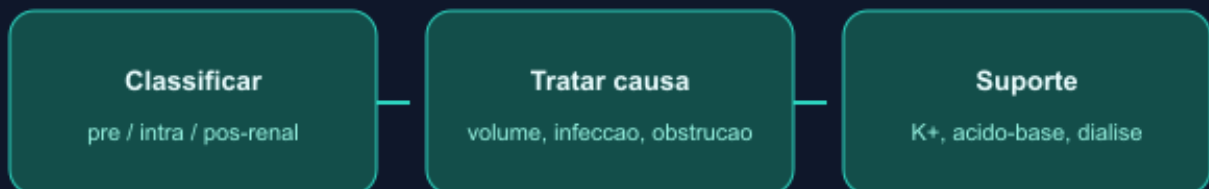
Lembre - Pistas de classificação

Pré-renal: hipovolemia/baixo débito, FENa baixa, urina concentrada — responde a volume se rim íntegro. Intrínseca: NTA, glomerulonefrite, AINEs/contraste. Pós-renal: globo, HBP, cálculos bilaterais — USG de vias urinárias.

Fluxo de prova: volume/perfusão !' excluir obstrução !' manejar complicações e nefrotóxicos.

Abordagem da IRA

Classificar -> tratar causa -> suporte



Conduta prática

- Rever medicações: IECA/BRA, AINE, diuréticos, aminoglicosídeo, contraste
- Volume: cristaloides se hipovolemia; evitar sobrecarga no anúrico
- USG renal se suspeita obstrutiva ou causa não óbvia
- Monitorar diurese, K z, ECG, bicarbonato e ureia

Indicações clássicas de diálise (AEIOU)

Letra | Indicação

- A | Acidose metabólica refratária
- E | Eletrólitos (hiperK refratária)
- I | Intoxicações dialisáveis
- O | Overload (edema pulmonar refratário)
- U | Uremia sintomática (pericardite, encefalopatia)

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Hipercalcemia com alterações no ECG é emergência — cálcio EV estabiliza membrana antes de 'só pedir gasometria de novo'. Insulina+glicose, beta-agonista e diálise conforme resposta.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Estágios KDIGO por creatinina e débito urinário padronizam o diagnóstico e a gravidade da LRA.

Basta creatinina OU débito urinário para estagiar (o pior prevalece).

KDIGO LRA - creatinina

Estágios 1-3

1: Cr x1,5-1,9 ou +0,3 mg/dL em 48h	1
2: Cr x2,0-2,9	2
3: Cr x3 ou ≥ 4 ou TRS	3

Critério tempo: aumento em 48h ou 7 dias

Débito urinário complementar ao estágio por creatinina.

KDIGO LRA - debito urinario

Oliguria

1: $<0,5$ mL/kg/h por 6-12h	1
2: $<0,5$ mL/kg/h por ≥ 12 h	2
3: $<0,3$ mL/kg/h ≥ 24 h ou anuria 12h	3

Anuria 12h = estagio 3

Pré-renal vs intrínseca (ideia)

| Pré-renal | NTA (intrínseca)

FeNa | $< 1\%$ | $> 2\%$

U/P creatinina | > 40 | < 20

Sedimento | sem cilindros/escasso | cilindros granulosos

Resposta a volume | melhora | pouca/nenhuma

Indicações clássicas de diálise (AEIOU)

- A — Acidose refratária
- E — Eletrólitos (hiperK refratária)
- I — Intoxicações dialisáveis
- O — Overload (edema pulmonar refratário)
- U — Uremia sintomática (pericardite, encefalopatia)

Conduta inicial

Dica - Conduta inicial

Suspender nefrotóxicos, ajustar doses, hidratar se hipovolemia, tratar obstrução (pós-renal), monitorar K e volume.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.
www.medhubr1.com.br - MedHub R1